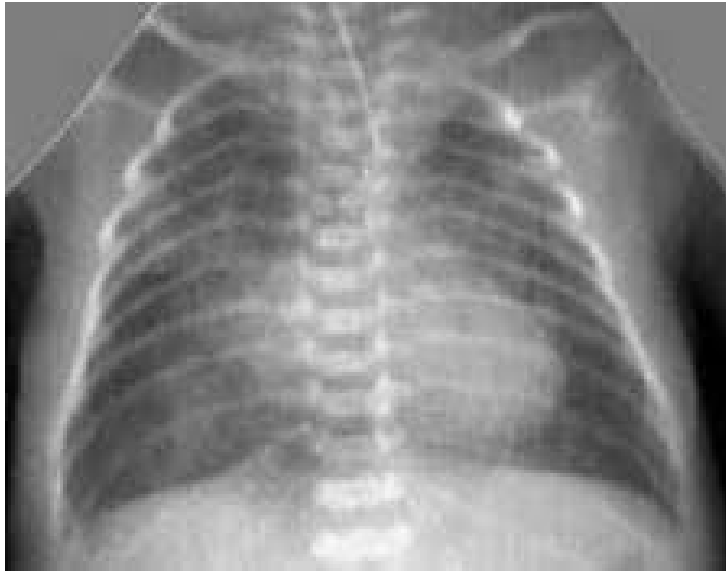


Ви лікар-педіатр-неонатолог акушерського стаціонару.

Ви прийшли до пологової зали, дитина від III вагітності, що проходила з загрозою переривання в 22 тижня, II передчасні фізіологічні пологи, термін гестації 30 тижнів. Маса при народженні — 1380,0 г, зріст – 36 см. Дихання спонтанне, неритмічне з епізодами апное по 5-6 сек. Профілактика РДС не проводилась.

Ви бачите стан дитини середньої важкості, тяжкість обумовлена респіраторними розладами, періоральний ціаноз. ЧД 66/хв. з втягінням міжреберних проміжків і грудини. Аускультативно дихання ослаблене, в нижніх відділах не прослуховується. За шкалою Сільвермана 3 бала. Позитивний оксидантний тест. Тони серця приглушені, ритмічні, ЧСС 154 уд/хв.

Дані рентгенологічного обстеження



Біохімічний аналіз крові

Кислотно-лужний стан (пуповинна кров):

pH - 7,0 (7,25-7,35)

дефіцит основ (BE) - 6 ммоль/л (до -6,0)

Глюкоза крові: 3,9 ммоль/л (2,6-5,0)

Алгоритм виконання		Форма представлення
1.Продемонструвати навички комунікації.		
1.1	Встановити контакт з колегами та жінкою, яка щойно народила (привітатись, представитися, позначити свою роль). Коректне розташування лікар-пацієнт	Сказати Доброго дня. Я лікар педіатр-неонатолог.
1.2	Отримання інформаційної згоди на проведення клінічного обстеження дитини	Сказати У дитини стан середньої важкості, я маю надати невідкладну допомогу. (Інформована згода надана жінкою на

		надання невідкладної допомоги дитині при надходженні в акушерський стаціонар)
2.Збір скарг та анамнезу		
2.1	Скарги (зі слів колег)	Сказати:Які скарги? Очікувана відповідь: Дихання спонтанне, неритмічне з епізодами апное по 5-6 сек.
2.2	Акушерський анамнез	Сказати: «Який термін гестації та перебіг вагітності? Профілактика РДС?» Очікувана відповідь: «ІІІ вагітність, що проходила з загрозою переривання в 22 тижня, ІІ передчасні пологи.Профілактика РДС не проводилась.»
2.3	Перебіг пологів	Сказати: «Які особливості перебігу пологів?» Очікувана відповідь: пологи фізіологічні. Вага при народженні 1380 г».
3.Об'єктивне обстеження		
3.1	Обробити руки на гігієнічному рівні та вдягнути захисну маску і рукавички, обробити оліву та мембрани фонендоскопу серветкою з антисептиком	Виконати/сказати Будемо вважати, що руки та фонендоскоп оброблені
3.2	Оцінити загальний стан.	Сказати:«Стан дитини середньої важкості, тяжкість обумовлена респіраторними розладами, періоральний ціаноз»
3.2	Обстеження дихальної та серцево-судинної системи	Сказати:«ЧД 66/хв. з втягінням міжреберних проміжків і грудини. Аускультативно дихання ослаблене, в нижніх відділах не прослуховується. За шкалою Сільвермана 3 бала. Позитивний оксидантний тест. Тони серця приглушені, ритмічні, ЧСС 154 уд/хв.»
4.Діагностика		
4.1	Визначити результати кислотно-лужного балансу крові, рівня глікемії	Сказати: респіраторний ацидоз, нормоглікемія
4.2	Оцінити результати рентгенологічного обстеження органів грудної клітки	Затемнення легень неінтесивні обширні за рахунок гіпопневмотозу з обох сторін, нечіткість контуру тіні серця, повітряна бронхограма – ознаки РДС 1 ступеню.

4.3	Визначити провідний синдром	Сказати:синдром гіпоксії
-----	-----------------------------	--------------------------

4.4	Встановити клінічний діагноз	Сказати:Респіраторний дистрес синдром, легкого ступеня.
5.Визначення тактики ведення та лікування		
5	Призначити подальшу тактику ведення пацієнта	Санація дих шляхів, введення сурфактанту інтратрахеально, кисень, СРАР(сіпап) через назальні канюлі. переводимо дитину у відділення виходжування недоношених новонароджених.
6.Профілактика та пропаганда здорового способу життя		
6	Рекомендувати профілактичні заходи	Сказати:здоровий спосіб життя жінки, грудне вигодовування, загартовування
7. Інше (в т.ч. легальні та етичні аспекти)		
7	Інформування батьків про можливі ризики та етичні аспекти	Сказати:Ви повинні знати про можливі ускладнення РДС – розвиток бронхолегеневої дисплазії, дих недост

